

11 - 07- Les métastases cérébrales - Pr. Ait Benali

Nous allons très brièvement parler des métastases cérébrales. Juste quelques deux ou trois plaques pour vous donner l'essentiel. Les métastases cérébrales sont du tumeur cérébral secondaire, à un cancer notamment sur tumeur bronchique ou à un cancer du sein chez la femme.

Et viennent ensuite les cancers de la prostate, du rein, cancer digestif, le mélanome. Mais parfois, sachez que le cancer primitif peut ne pas être détecté, malgré plusieurs investigations chez un patient. Ce qu'il faudrait noter en matière de métastases cérébrales, c'est qu'à partir du moment de la survenue des métastases cérébrales, l'évolution est très souvent rapide.

Ce sont des lésions de mauvais pronostic. Bien que ce dernier temps, il y a eu du progrès de la radiothérapie stéréotaxique, de la radiochirurgie, malgré ces progrès, ces lésions restent de mauvais pronostic. Sur un plan imagerie TDM ou IRM, il s'agit le plus souvent d'images qui peuvent être multiples, arrondies, de densité variable, ou d'intensité variable si c'est une IRM, souvent multiples, avec prise de contraste annulaire, parfois nodulaire, avec surtout beaucoup de tumeurs cérébrales.

Les métastases accompagnent du tumeur cérébrale et un effet de masse sur les structures médianes. Vous voyez ici les images caractéristiques des métastases. Vous avez un nodule ici, vous avez beaucoup de tumeurs cérébrales, au niveau de la base postérieure aussi.

Là, vous voyez une image frontale droite avec beaucoup de tumeurs autour, c'est une image caractéristique des métastases. Ici, vous voyez une image du centre oval, avec des tumeurs aussi autour. Regardez ici un scanner qui montre une multitude de nodules, ce qu'on appelle l'aspect de millière cérébrale, c'est des métastases multiples.

Regardez sur cette IRM, ici, en bas à droite, vous voyez ici une image des métastases ici, là, il y en a une autre là, etc. Voilà. Puis, vous avez ici une lésion, vous voyez aussi l'os, une lésion évocatrice des métastases cérébrales.

Nous en arrivons au traitement, la dernière plaque. Il faudrait savoir que le traitement des métastases cérébrales fait appel à la chirurgie du XRH chaque fois que c'est possible, sous vue d'une radiothérapie. Pour une chirurgie, en cas de métastase unique, accessible chirurgicalement, si le concept primitif est bien contrôlé, en l'absence d'autres localisations métastatiques, si vous avez, par exemple, l'impression qu'il y a des métastases cérébrales multiples, viscérales multiples, pulmonaires, hépatiques, articulaires, cérébrales, eh bien, on peut s'abstenir, ce n'est pas une indication chirurgicale idéale.

Quelquefois, on peut aussi intervenir, on peut faire une chirurgie crânienne pour une lésion encéphalique qui pose un problème diagnostique. Quand on n'est pas sûr que c'est une métastase, on opère le patient pour avoir retiré la lésion et avoir un diagnostic anatomique pathologique. Dans les autres cas, en dehors de ces situations-là, le traitement va faire appel à la

radiothérapie, avec ou sans chimiothérapie, mais sachez que le pronostic de ces métastases cérébrales reste mauvais dans l'ensemble.

Je vous remercie.